

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	食道癌 Esophageal Cancer				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q03-W-K04	SI 朱卉愉	97 年 05 月 31 日	111 年 11 月 08 日	114 年 10 月 02 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	
版本/總頁數	第 3.4 版/9 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	

一、目的

讓護理人員了解食道癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

食道癌是引起食道阻塞最常見的原因之一，好發於男性，在食道的任何部位都可發生癌症病變，但以中間和下三分之一最常見，百分之九十屬於鱗狀上皮細胞癌 (squamous cell carcinoma)。

（二）症狀

1. 吞嚥困難：95%食道癌的病人以吞嚥困難為最初表徵，會有異物感，早期可能只對固體食物，最後逐漸連液體也無法吞嚥。
2. 吞嚥疼痛：當腫瘤逐漸變大，可能會有胸骨後方疼痛及喉嚨痛甚至經常噎到，或有飽脹情形。
3. 食慾不振、體重減輕、營養不良、胃痛、嘔吐、咳嗽。
4. 聲音嘶啞：因癌細胞侵犯喉返神經。食道癌早期幾乎沒有明顯的症狀。至晚期時，可能會出現吐血、黑便、咳血、咳嗽等症狀。如果侵蝕到鄰近的主動脈，甚至可能會發生大出血的嚴重狀況，依不同轉移的器官表現不同的症狀。如果轉移到頸部淋巴結，會表現出淋巴結腫大；轉移至肺部，會表現出咳嗽、咳血、

主題名稱	食道癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K04	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	2/9

胸痛等症狀；轉移至骨骼，會出現骨骼疼痛的症狀；轉移至肝臟，會出現黃疸、腹脹、腹痛等症狀。

（三）常見檢查

1. 食道內視鏡檢查及切片：醫生可透過食道鏡刷下食道壁的細胞或取出部份組織做組織切片檢查，與食道攝影檢查兩者相輔相成。病理組織切片合併細胞學檢查的診斷正確率可以達到 98%。而單獨組織切片的診斷率只有 94%，單獨細胞學檢查的診斷只有 88%。
2. 食道 X 光攝影：病人喝下鋇顯影劑，可附著於食道表面透過 X 光而讓病變處、食道阻塞的程度及病變的範圍等顯示出來。
3. 電腦斷層攝影(CT)：可用來鑑定原發性病變的大小及結節侵犯的大小。
4. 其他：胸部 X 光、腹部超音波、正子放射斷層攝影(PET)、骨骼掃描檢查、縱膈腔鏡等以評估食道癌是否已轉移。

（四）常見治療

1. 外科療法
 - (1) 食道切除術：包含次全或全食道切除術，當症狀出現後腫瘤已非常大，且可能有遠處淋巴之浸潤施行之。
 - (2) 食道胃吻合術：此方法多使用於食道中、下段腫瘤，且癌細胞未浸潤胃部，須開胸及剖腹手術。
 - (3) 結腸繞道手術：又稱食道重建術，用於不適合食道胃吻合術之病人。是將一段空腸或結腸（通常是降結腸）一端接於切除後的殘餘食道末端，另一端接在胃部，建立另一個食道通道。
2. 放射線治療：使用高能量的放射線或粒子殺死癌細胞。病灶位置在食道上三分之一時採用，可以減少腫瘤大小，主要適用於緩解症狀通常第一階段的放射線治療需 6 到 8 週，因為食道的組織對於放射線非常敏感，一次大劑量的放射線治療會導致食道萎縮或狹窄，因此採用小劑量而多次的治療方法。
3. 化學療法：是經由口服或靜脈注射予抗癌藥物，達到對抗或殺死癌細胞，而直

主題名稱	食道癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K04	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	3/9

接將 5-FU 及 Cyclophosphamide 注入腫瘤處，可緩解吞嚥困難。

- 姑息療法：無法施行手術者，做胃造瘻或迴腸造瘻可暫時解除吞嚥困難，並供應營養，及減輕不適的症狀。

(五) 護理問題

1. 呼吸道清除功能不良／咳嗽能力降低。
2. 排便異常：腹瀉／腸胃道無法適應灌食方式。
3. 疼痛不適／手術傷口。
4. 易感染／侵入性治療及第一道防線不完善。

(六) 護理措施

1. 呼吸道清除功能不良／咳嗽能力降低

- (1) 評估呼吸狀況，記錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽和分泌物的特性。
- (2) 監測脈搏血氧定量法和動脈血液氣體分析值。
- (3) 依醫囑送檢體做培養、細胞學和敏感試驗。
- (4) 協助病人採高坐臥姿；至少每 2 小時翻身一次以移動分泌物。
- (5) 教導病人深呼吸後有效咳嗽。
- (6) 必要時，抽吸呼吸道，抽吸時間以 10 秒為限。
- (7) 抽吸前後，先給予氧氣或鼓勵深呼吸，使肺過度充氣。
- (8) 依醫囑執行胸部物理治療，例如叩擊、姿位引流。
- (9) 提供病人足夠氧合狀態：鼓勵經口攝取液體或依醫囑維持靜脈輸液。
- (10) 依醫囑給予濕潤的氧氣，尤其當病人身上有人工氣管時。
- (11) 依醫囑給予藥物，例如支氣管擴張劑、類固醇、祛痰劑和抗生素。
- (12) 記錄護理措施的效果。

2. 排便異常：腹瀉／腸胃道無法適應灌食方式

- (1) 向病人及家屬說明腹瀉的原因，減輕其焦慮不安。
- (2) 每班觀察及記錄大便形狀、次數、量、顏色。
- (3) 監測生命徵象的變化。

主題名稱	食道癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K04	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	4/9

(4)提供安靜的環境,給予足夠的休息及睡眠。

(5)監測血中檢驗值的變化（如電解質、白血球、白蛋白）。

(6)注意體重及紀錄輸出入量。

(7)觀察皮膚有無脫水情形。

(8)注意肛門皮膚的清潔和乾燥。

(9)依醫囑靜脈給液。

3. 疼痛不適／手術傷口

(1)評估病人的疼痛程度及特徵。

(2)評估疼痛加劇的原因。

(3)減少或排除疼痛的因素。

(4)教導利用枕頭或毛毯支持疼痛部位。

(5)教導放鬆技巧如：深呼吸、背部按摩、冥想。

(6)予轉移注意力如：音樂、書籍、聊天。

(7)依醫囑予物理治療如：熱敷、冰敷。

(8)在病人選擇疼痛控制方法時，給予支持與指導。

(9)教導咳嗽或改變姿勢時，以手或束腹帶固定傷口。

(10)與病人及家屬共同討論可控制引發疼痛的因素之方法。

(11)避免腹部用力如哭鬧蹲姿、用力解便、咳嗽，預防傷口疼痛或裂開。

(12)依醫囑給予止痛劑。

(13)評值疼痛控制技巧的效果。

(14)評估藥物的效果及副作用。

(15)衛教病人咳嗽時可按壓傷口，避免牽扯疼痛。

(16)鼓勵家屬多予陪伴。

4. 易感染／侵入性治療及第一道防線不完善

(1)觀察與評估皮膚受損情形（是否有紅、腫、熱、痛現象）。

(2)執行侵入性治療及換藥時保持無菌技術。

主題名稱	食道癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K04	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	5/9

- (3)每 1 小時監測生命徵象。
- (4)評估病人營養狀況，視需要給予飲食衛教，教導選擇高熱量、高蛋白、高維生素的飲食（肉類、蛋類、魚類、海鮮類、綠色蔬菜等），以促進傷口的修復再生。
- (5)提供每日 1-2 次的皮膚護理以維持皮膚表面乾燥。
- (6)每天或視需要運用無菌技術更換敷料,並觀察周圍皮膚狀況。
- (7)每班檢查及紀錄傷口有無分泌物、氣味，必要時收集標本，以監測有無感染情形。
- (8)每次接觸病人前、後洗手。
- (9)與醫師討論儘早拔除侵入性治療的管子。

（七）衛教指導

1. 手術前的護理

- (1)口腔護理：教導病人正確的刷牙方式，並告知每天早晚及進食後，應皆刷牙。
- (2)可以溫開水、生理食鹽水、市售漱口水等來漱口，以去除異味及舌苔，維持口腔的清潔。
- (3)改善營養及重建水份與電解質的平衡：在飲食可嚥下的範圍，給予高蛋白、高熱量、低渣飲食，例如：奶類、肉汁、魚、蛋、煮爛的瘦肉、豆漿、粥、過濾後的果汁，並正確的觀察飲食內容、攝取量、營養狀態、定期量體重。
- (4)給予完全腸道外營養法(Total parenteral nutrition, TPN)：對於不能由口進食或口服攝取不足及虛弱的病人，須由 TPN 進行補充營養。
- (5)掌握全身狀態：手術前正確地掌握病人的一般狀態，例如：生命徵象、皮膚狀態、營養狀態、體重的增減、血液、電解質、排泄狀況、檢查報告、相關症狀、併發症、過去病史及家屬的反應等。

主題名稱	食道癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K04	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	6/9

2. 給予手術後的護理

- (1)維持呼吸道通暢：可給予氧氣療法，為了預防術後呼吸困難，使用人工呼吸器時，應使用潮濕器或依醫囑給予噴霧治療。早期作深呼吸運動，將呼吸道分泌物及痰液咳出，或給予抽痰，以確保呼吸道通暢、清潔，並密切觀察有無呼吸困難的情形。
- (2)姿勢：採半坐臥勢，搖高床頭 30 度或在頭與肩下墊一枕頭，以防胃內容物逆流。進食後採坐姿至少 2 小時，以防止食物逆流造成吸入性肺炎。
- (3)鼻胃管及胸腔引流管的護理：需注意引流管是否通暢，若接抽吸器則須注意功能的完整性。術後 6 到 12 小時鼻胃管會有少量鮮紅色引流液，之後會逐漸轉黃綠色，每日應觀察評估引流情形，待吻合處完全癒合後才可將胃管移去。胸腔引流管須維持胸腔內安全負壓，採重力原理使引流液流入胸瓶。
- (4)飲食：禁食 4 至 7 天，先由靜脈注射供應營養，直到吻合部癒合，可容許病人喝少量的水，約 30 到 60cc，若一切情況良好，可開始漸進式進食，須注意有無水分滲入縱膈腔的症狀，如頭痛、體溫上升、呼吸困難等現象。教導給予少量多餐的溫和飲食或質地較軟或半流質、流質飲食（低渣），選擇高蛋白、高熱量食物，進餐後 2 到 3 小時保持上半身直立，勿平躺。
- (5)注意口腔及皮膚護理：可使用溫和的小蘇打水或生理食鹽水給予漱口清潔口腔。手術後 2-3 日為了保護吻合部，應將唾液吐出，對於有嚥下唾液危險的患者，避免漱口，應用口腔棉棒清拭口腔。
- (6)觀察全身的狀態：按時觀察紀錄生命徵象、尿量、尿比重、血液、電解質等，注意插管的引流量、性狀、有無出血、腫脹、感染徵象，保持插管處無菌。
- (7)預防和早期發現術後併發症：呼吸表淺，不易將痰和口腔內分泌物咳出，容易產生肺泡萎縮、肺炎、膿胸等，故需衛教深呼吸和咳嗽。也要注意傷口是否有裂開、出血及感染情形。需注意有無心臟衰竭，故隨時觀察生命

主題名稱	食道癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K04	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	7/9

徵象。術後經過 3 到 5 天可能出現頸部、背部的不舒服、疼痛、體溫上升、呼吸困難、吞嚥痛。

(8)手術後傷口疼痛：教導翻身、咳嗽時傷口加壓支撐、必要時依醫囑給予止痛劑。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 蔡仁貞、梁穎、洪美英、高秋惠、楊易宏、張效煌、李瓊淑(2020)・消化系統疾病病人的護理・新編內外科護理學下冊(第八版, 301-498 頁), 華杏。
- (二) 謝伊晴、邱哲琳、楊雀戀(2018)・食道癌病人的營養照護・臨床醫學月刊, 82(6), 720-724。
- (三) 蘇鈺婷、楊宜霖、楊淑貞(2020)・一位罹患食道癌執行食道重建手術病人的護理經驗・馬偕護理雜誌, 14(1), 14-24。
- (四) 葉麗敏、陳德坤(2022)・一位食道癌手術後個案入住加護病房之護理經驗・澄清醫護管理雜誌, 18(2), 74-83。

七、附件

(略)

主題名稱	食道癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K04	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	8/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定。	97 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	修改說明內容與錯別字。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1.醫護部改護理部。 2.刪除第六項參考資料(2000)及改正標點符號。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	更新第六項參考資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.2	1. 第三項說明內容部份刪修。 2. 新增參考文獻出處於內文中。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

